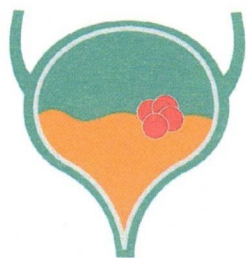


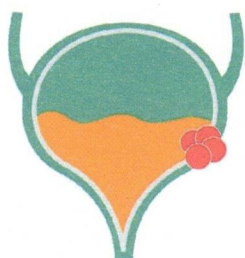
BLAASKANKER

VERSCHILLENDE BEHANDELINGEN BLAASKANKER



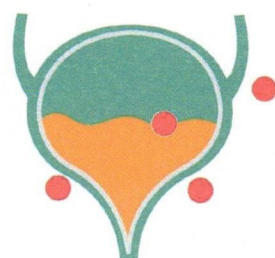
TURT EN BLAASSPOELINGEN

Als de tumor niet in de blaaspier gegroeid is.



CHEMOTHERAPIE, RADIOtherAPIE OF VERWIJDERING VAN DE BLAAS

Als de tumor in de blaaspier gegroeid is.



CHEMOTHERAPIE EN/OF IMMUNOTHERAPIE

Als de tumor uitgezaaid is.

Erasmus MC
Erasmus

leven met blaas- of

www.blaasofnierkanker.nl | www.erasm

Ronald de Wit licht toe: “Die BCG-spoelingen leiden tot een plaatselijke ontstekingsreactie en dat wekt een immuunrespons op. De eigen afweercellen neutraliseren de infectie. Als neveneffect vernietigen de afweercellen de aanwezige blaaskankercellen. Dus eigenlijk is dat een ouderwetse vorm van immuuntherapie.”

Hij vervolgt: “Als die BCG niet helpt of niet meer helpt en de blaaskanker komt weer terug, dan was eigenlijk de enige resterende behandeling de blaas te verwijderen. Als we dat niet doen dan is er zo’n 50% kans dat vroeg of laat toch een spierinvasieve blaaskanker ontstaat.”

Ontwikkelingen niet-spierinvasieve blaaskanker

In de afgelopen jaren zijn verschillende studies gedaan met immuuntherapie bij blaaskanker. Eerst met de immuuntherapie pembrolizumab. Maar ondertussen zijn er ook andere immuuntherapieën bij niet-spieerinvasieve blaaskanker, zoals nivolumab en durvalumab.

Ronald de Wit: “Onderzoek toont aan dat de immuuntherapie pembrolizumab bij 45% van de patiënten met niet-spieerinvasieve blaaskanker het zieke blaasweefsel volledig normaliseert. En we weten ook dat dat meer jaren kan aanhouden. Omdat we weten dat het effect van

immuuntherapie vaak heel lang kan aanhouden, en misschien ook wel definitief aanhoudt, is het denkbaar dat deze patiënten eigenlijk genezen zijn en dat ze dus hun blaas kunnen behouden na een of twee jaar immuuntherapie. Dat heeft ertoe geleid dat in Amerika pembrolizumab voor BCG refractair niet-spieerinvasieve blaaskanker is geregistreerd. In Europa is het nog niet zover, maar in Nederland zijn er wel verschillende studies met immuuntherapie bij niet-spieerinvasieve blaaskanker.”

Zoals de studie KEYNOTE 676. Deze studie vergelijkt BCG-spoelingen in de blaas met BCG-spoelingen plus immuuntherapie via een infuus. Patiënten met een hoog-risico niet-spieerinvasieve blaaskanker, die eerder BCG hebben gehad, maar bij wie de tumor terugkeert, kunnen deelnemen aan deze studie.

Alle patiënten krijgen de standaardbehandeling met opnieuw BCG-spoelingen. Via loting krijgt een groep daaraan toegevoegd de immuuntherapie pembrolizumab gedurende 18 tot 24 maanden. Daarna wordt het ziektebeeld gevolgd.

Een ander voorbeeld is de POTOMAC-studie. Dat is eenzelfde studie als de KEYNOTE 676, maar dan met de immuuntherapie durvalumab.